

ΟΞΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΛΓΟΣ – ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ

Γενικά: Με τον όρο «οξεία κοιλία» εννοούμε οποιαδήποτε αιφνίδια κι επείγουσα κατάσταση που εντοπίζεται στην κοιλιακή χώρα, μη τραυματικής αιτιολογίας, που χαρακτηρίζεται από οξύ κοιλιακό άλγος, σύσπαση ή μη των κοιλιακών τοιχωμάτων, ευαισθησία στην κοιλιά η οποία μπορεί να συνοδεύεται από γενικά συμπτώματα ή/και από εργαστηριακά ευρήματα.

Η οξεία κοιλία απαιτεί ταχεία διάγνωση, άμεση αντιμετώπιση, στενή παρακολούθηση και συνετή ταχεία λήψη απόφασης, είτε για χειρουργική επέμβαση ή για συντηρητική αγωγή.

Γενικά, ένας οξύς κοιλιακός πόνος διάρκειας άνω των 6 ωρών, με σύσπαση της κοιλίας, θεωρείται ότι προέρχεται από καταστάσεις χειρουργικής παθολογίας.

Η διαφορική διάγνωση του οξέος κοιλιακού άλγους αποτελεί σοβαρή κλινική πρόκληση, καθώς περιλαμβάνει πληθώρα παθολογικών και χειρουργικών καταστάσεων.

Χαρακτήρας του πόνου: Το άλγος στην κοιλιακή χώρα, είτε είναι άτυπο, είτε αφορά εικόνα οξείας κοιλίας, θα πρέπει να εξετάζεται, ανάλογα με τις εξής παραμέτρους:

- | | |
|-------------------------|--|
| ▶ Τρόπος ενάρξεως. | ▶ Πιθανές αντανakλάσεις του πόνου. |
| ▶ Ένταση του πόνου. | ▶ Συσχέτιση με λειτουργίες του πεπτικού. |
| ▶ Χαρακτήρας του πόνου. | ▶ Διάρκεια του πόνου. |
| ▶ Εντόπιση του πόνου. | ▶ Εξέλιξη (επιδείνωση) του πόνου. |

Το άλγος στην οξεία κοιλία μπορεί να είναι άτυπο, ασαφές, διάχυτο σε μεγάλο τμήμα της κοιλιακής χώρας ή εντοπισμένο και σαφώς καθοριζόμενο. Μπορεί επίσης να επεκτείνεται σε γειτονικές δομές ή να αντανakλά σε απομακρυσμένα σημεία (*ράχη, ώμος, πρίνεο*) ή όργανα. Τα κύρια αίτια του διάχυτου, ασαφώς εντοπισμένου, κοιλιακού άλγους, είναι:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| • Οξεία περιτονίτιδα. | • Οξεία γαστρεντερίτιδα. |
| • Μεσεντέριος ισχαιμία. | • Διαβητική κετοξέωση. |
| • Εντερική απόφραξη (ειλεός). | • Οικογενής Μεσογειακός πυρετός. |
| • Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου. | • Μη ειδικό κοιλιακό άλγος. |

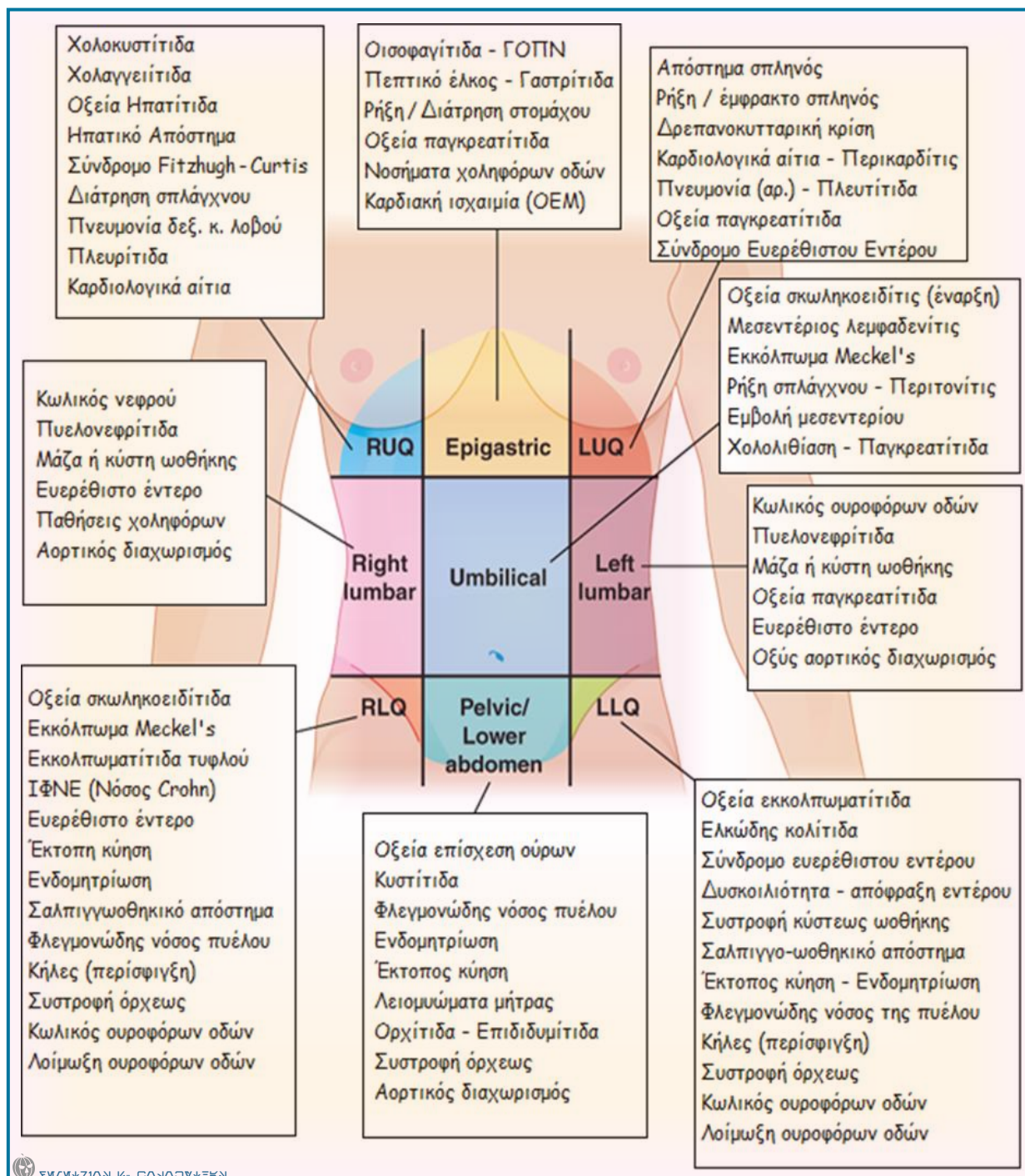
Ιστορικό & ατομικό αναμνηστικό: Η λεπτομερής λήψη ιστορικού, από τον ίδιο τον ασθενή ή από τους οικείους του αποτελεί σημαντικό βοήθημα για τον ιατρό στην κλινική διάγνωση. Ελέγχεται η πιθανή ύπαρξη συστηματικής νόσου (*ΑΥ, ΣΝ, ΑΦ, ΣΔ, νεόπλασμα, αγγειίτιδες*), η συστηματική χρήση κορτικοστεροειδών ή άλλων φαρμάκων που μπορεί να στρεβλώσουν την κλινική εικόνα (*μορφίνη, σπασμολυτικά, κατασταλτικά*), το ιστορικό ακτινοθεραπείας ή χειρουργικών επεμβάσεων στην κοιλιά, επίσης ελέγχουμε για ιδιάζουσες συνήθειες, έξεις ή εξαρτήσεις (*τριχοτιλλομανία, κατάποση ξένων σωμάτων, κατάποση δερμάτων ναρκωτικών*).

Κλινική εξέταση: Η κλινική εξέταση του ασθενούς με οξύ κοιλιακό άλγος ξεκινά από την είσοδο του στο ιατρείο και με την λήψη του ιστορικού, πριν ακόμα αγγίξουμε τον άρρωστο. Το βάδισμα, η στάση του σώματος, η συμπεριφορά, η έκφραση του προσώπου, η έντονη ανησυχία, ο χαρακτήρας της ομιλίας και των αναπνοών, το χρώμα του δέρματος, η θέση του αρρώστου στο εξεταστικό κρεβάτι και η αναζήτηση ανταλγικών θέσεων, είναι παράμετροι που πρέπει να αξιολογούνται και μας καθοδηγούν στην κλινική εξέταση και στη διάγνωση.

Ελέγχουμε τα **ζωτικά σημεία** (π.χ. μέτρηση της ΑΠ και από τους δύο βραχίονες, σφύξεις, αναπνευστική συχνότητα, SpO_2 , θερμοκρασία), μετράμε τα επίπεδα γλυκόζης και εκτελούμε άμεσα ΗΚΓ. Ασθενής με αρρυθμία (κολπική μαρμαρυγή - ΑΦ) και με οξύ κοιλιακό άλγος, θεωρείται ότι πάσχει από εμβολή της μεσεντερίου αρτηρίας έως αποδείξεως του αντιθέτου.

Η κλινική εξέταση της κοιλίας επιτελείται με τις γνωστές εξεταστικές μεθόδους που είναι: η επισκόπηση, η ακρόαση, η ψηλάφηση και η επίκρουση. Η ακρόαση της κοιλιάς μάλιστα πρέπει να γίνεται πριν από την επίκρουση και την ψηλάφηση, διότι εάν ακολουθήσει αυτές, μπορεί να οδηγηθούμε σε λανθασμένα συμπεράσματα λόγω μεταβολής των εντερικών ήχων. Τονίζεται ότι η κλινική εξέταση της κοιλιάς πρέπει να συμπεριλαμβάνει πάντοτε την εξέταση των έξω γεννητικών οργάνων του ασθενούς και των ευένδοτων κοιλιακών σημείων για κήλη.

Εξετάζοντας την κοιλία ενδελεχώς, αναζητούμε ειδικά - οδηγά για τη διάγνωση - σημεία (π.χ. *Murphy*, *Rovsing*, *McBurney*, *Blumberg*, *Lanz*, *Boas*, *Cullen*, *Dunphy*, *Markle*, *Carnett*, *Fothergill*, κ.ά.) και εντοπίζουμε τα κλινικά σημεία και συμπτώματα σε κάθε τεταρτημόριο, λαμβάνοντας πάντοτε υπ' όψιν τη διαφορική διάγνωση διαφόρων κλινικών καταστάσεων, αναλόγως της εντοπίσεως τους, όπως φαίνεται τοπογραφικά στην παρακάτω εικόνα.



Παρακλινικές εξετάσεις: Διενεργούμε γενική αίματος και αδρό βιοχημικό έλεγχο (γλυκόζη, ουρία, κρεατινίνη, K^+ , Na^+ , Ca^{++} , AST/ALT , $Bil(t/d)$, γ -GT, ALP , LDH , CPK , αμυλάση ορού, αμυλάση ούρων, CRP , INR , PT , a -PTT, D -Dimers, πιθανώς $CPK-MB$ και $Τροπονίνη-cTnI$), γενική ούρων, test κύσεως, καθώς και αέρια αρτηριακού αίματος (εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα στο ΚΥ ή στο ΤΕΠ) για τον έλεγχο και αξιολόγηση των μεταβολικών διαταραχών.

Απαραίτητη θεωρείται η ακτινογραφία θώρακος (F/P) και κοιλίας σε όρθια θέση και σε πλάγια θέση decubitus για ασθενείς που δεν δύναται να σταθούν όρθιοι. Πιθανώς, κι εφόσον επίσης υπάρχει η δυνατότητα, διενεργούμε και υπερηχογράφημα (U/S) άνω και κάτω κοιλίας.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Η αντιμετώπιση του ασθενούς, που προσέρχεται ή διακομίζεται στο ΤΕΠ με εικόνα οξείας κοιλίας, επιτελείται παράλληλα με την κλινική και εργαστηριακή διερεύνηση. Σε ασθενή σε κωματώδη κατάσταση, αξιολογούνται αρχικώς τα A, B, C, D, E και διενεργούμε μια αδρή νευρολογική εξέταση, εκτιμώντας το επίπεδο συνείδησης (GCS ή κλίμακα AVPU).
 2. Μεριμνούμε για επαρκή οξυγόνωση του ασθενούς, ώστε να διατηρείται $SpO_2 > 90-92\%$, χορηγώντας O_2 στα 4-8 lt/min, με απλή προσωπίδα οξυγόνου ή μάσκα Venturi (24-31%).
 3. Τοποθετείται 3way φλεβική γραμμή, μεγάλου εύρους (#16-18G) και στα δύο άνω άκρα.
 4. Λαμβάνουμε αίμα και ούρα, για εργαστηριακό έλεγχο. Εκτελούμε ΗΚΓ και ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία του ασθενούς (ΑΠ, σφύξεις, αναπνευστική συχνότητα, SpO_2 , θερμοκρασία), τον σφυγμό στις μηριαίες αρτηρίες (άμφω) και τα επίπεδα γλυκόζης με Dextro-stick.
 5. Χορηγούμε αρχικά κρυσταλλοειδή, 1000 ml NaCl 0,9% ή R/S ή R/L, αναλόγως της ΑΠ.
 6. Τα αρχικά βήματα στον θεραπευτικό αλγόριθμο, σε ασθενή με οξεία κοιλία, στο επίπεδο της ΠΦΥ, κατευθύνονται ανάλογα με την κλινική μας υποψία για το γενεσιουργό αίτιο. Έτσι, διαφορετικά θα δράσουμε σε ασθενή με υποψία διάτρησης σπλάγχχνου και εντελώς διαφορετικά σε ασθενή με πιθανό αορτικό διαχωρισμό ή σε άλλον με αποφρακτικό ειλέο. Άλλωστε, η δική μας αρχική θεραπευτική αντιμετώπιση είναι κυρίως υποστηρικτική και ανακουφιστική, ενώ η οριστική διάγνωση και τελική θεραπεία θα γίνει στο νοσοκομείο.
 7. Επί έντονου άλγους στο επιγάστριο, με συνοδά επεισόδια εμέτων, χορηγούμε εντός ορού 100 ml N/S, 1-2 amp. Σιμετιδίνη (Tagamet) και 1 amp. PPI, μαζί με 1 amp. Primperan. Σε εμμένουσα έμεση, μπορεί να χορηγηθεί 1 amp. Ondansetron 4 mg σε 100 ml N/S (iv).
 8. Εφόσον το κοιλιακό άλγος είναι έντονο και διάχυτο, επιδεινούμενο και μη ανεκτό πλέον από τον ασθενή, χορηγούνται αναλγητικά. Τοποθετούμε δηλαδή, 1 amp. Dynastat 40 mg (ή 1 amp. *Viaxal 50 mg*) εντός ορού 100-250 ml NaCl 0,9%, ή 1 amp. Vurdon 75 mg (im), καθώς και 1 fl. 100 ml Παρακεταμόλη 1 gr (*Apotel*), ώστε να χορηγηθούν σε 20-30 λεπτά. Σε επιμονή ή επίταση του άλγους, μετά από παρέλευση 20-30 λεπτών ή ευθύς εξ αρχής, χορηγούνται 1 amp. Τραμαδόλη 100 mg (*Tramal*) σε 100 ml N/S εντός 20-30 λεπτών (iv) ή 1 amp. Πεθιδίνη (im) ή 1 amp. Δεξτροπροποξυφαίνη 75 mg (*Romidon/Zideron*) (im).
- Η αναλγησία** κρίνεται απαραίτητη στον ασθενή με οξεία κοιλία, ειδικά στις περιπτώσεις που συνυπάρχει καρδιαγγειακή νοσηρότητα (ΑΥ, ΣΝ), η οποία πιθανώς να επιδεινωθεί λόγω του οξέος κοιλιακού άλγους. Η παλαιά θεώρηση της «αποφυγής χορήγησης αναλγησίας, ώστε να μην καλυφθεί η κλινική εικόνα στην οξεία κοιλία μέχρι την τελική εξέταση από τον ειδικό χειρουργό», κρίνεται εντελώς παρωχημένη, απάνθρωπη, αλλά και ιδιαιτέρως επισφαλής! **Απαγορεύεται η χορήγηση σπασμολυτικών (*Buscopan*), μέχρι την οριστική διάγνωση.**
9. Τοποθετείται ρινογαστρικός σωλήνας Levin, για την αποσυμφόρηση και ανακούφιση του στομάχου, αλλά και για έλεγχο του περιεχομένου του στομάχου για πιθανή αιμορραγία.
 10. Εκτελούμε δακτυλική εξέταση, για ανεύρεση αιμορραγίας, μάζας στο ορθό ή κοπρόλιθο.
 11. Τοποθετείται καθετήρας Foley (14-16 fr), για αποσυμφόρηση της ουροδόχου κύστης και για τη μέτρηση των αποβαλλόμενων ούρων, που πρέπει να κυμαίνονται στα 4-6 ml/kg/h.
 12. Σε περίπτωση ανησυχίας ή έντονης ψυχοκινητικής διέγερσης του ασθενούς, επιχειρούμε ήπια καταστολή (εφόσον δεν έχουν ήδη χορηγηθεί οπιοειδή ως αναλγητικά), με χορήγηση ενδοφλεβίως 1 amp. Διαζεπάμης 10 mg (*Stedon*), σε 100 ml N/S, εντός 20-30 λεπτών.
 13. Εφόσον μετρηθούν αέρια αρτηριακού αίματος, στους ασθενείς με βαριά οξέωση ($pH < 7,1$) και ιδίως σε αυτούς με χρόνια νεφρική νόσο, μπορεί να χορηγηθούν Διττανθρακικά. Έτσι, διαλύουμε 1-2 amp. Διττανθρακικό Νάτριο ($NaHCO_3$) σε 100-250 ml NaCl 0,9% ή D_5W (1 amp. 4% περιέχει 400 mg ή 4,8 mEq $NaHCO_3$) και το διάλυμα χορηγείται προσεκτικά εντός 30-45 λεπτών ή μέχρι την διακομιδή του ασθενούς στο νοσοκομείο.
 14. Άμεση διακομιδή στο νοσοκομείο, συνοδεία ιατρού, υπό συνεχές monitoring (ΗΚΓ, ΑΠ, σφύξεις, SpO_2 , RR, διούρησης), για περαιτέρω διερεύνηση και οριστική αντιμετώπιση.